

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱   | 癌症疼痛照護<br>The Care of Cancer Pain |     |         |      |                 |
|--------|-----------------------------------|-----|---------|------|-----------------|
| 編號     | A31000-Q03-W-K14                  | 制定者 | N17 陳瑩婕 | 公布日期 | 99 年 01 月 20 日  |
| 制定單位   | 護理部                               | 核准者 | 吳姿蓉     | 修正日期 | 115 年 01 月 06 日 |
| 版本/總頁數 | 第 3.9 版/14 頁                      | 審查者 | 劉俞均     | 檢閱日期 | 115 年 01 月 06 日 |

## 一、目的

讓護理人員了解癌症疼痛照護原則，緩解病人疼痛不適之症狀，改善其舒適程度，提升照護品質。

## 二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

## 三、說明

癌症疼痛之定義、分類、症狀、評估及處理原則：

（一）定義：疼痛是一種和實際或潛在組織受損有關的一種主觀的不愉快感覺或情緒經驗；也是許多癌症病人最害怕的情境，深深的影響其日常活動、生活動機、與家人朋友的互動，及整體的生活品質，疼痛照護是為減緩疼痛所導致的不適及維持病人的生活品質。

（二）癌症疼痛的分類

### 1.依疼痛發生的時間分類

(1)急性疼痛：肇因於人體組織受到傷害，受損的組織痊癒後疼痛也跟著消失，屬於可逆性，通常伴隨自主神經系統的生理症狀，如：心跳及呼吸加速、血壓升高、冒汗、瞳孔放大等。

(2)慢性疼痛：疼痛持續的時間超過三個月以上或超出正常組織痊癒所需的時間；或是因疾病過程導致疼痛持續；或是疼痛一再地、間歇性地發生，持續數月或數年之久。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 癌症疼痛照護           | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-K14 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 2/14 |

## 2. 依受侵犯之組織及器官引起之疼痛病徵分類

### (1) 體感性疼痛(somatic pain)

體表或肌肉骨骼受損引起的疼痛，通常是持續性可以確定部位的，其疼痛性質常為持續刺痛、銳痛、搏動性痛，此類疼痛對止痛藥物的反應最佳。

### (2) 內臟性疼痛(Visceral Pain)

引起的原因包括臟器的受損、中空器官的阻塞、平滑肌痙攣等。其特點為定位困難、常以悶痛及絞痛表現也可能出現自主神經障礙的症狀，如；噁心、嘔吐、低血壓、心跳過慢等。

### (3) 神經病變性疼痛(Neuropathic Pain)

神經受損或受壓所致，常會引起劇烈的疼痛，常需要合併使用治療疼痛輔助劑方能控制。其性質為變化，如：灼痛、刺痛、電擊痛等。患者也可能經歷各種不適的感覺，如：感覺異常(dysesthesia)、觸摸痛(alodynia)、痛覺過度(hypersthesia)或是痛覺遲鈍(hypalgesia)。

## (三) 癌症疼痛的症狀

|         |        |                                                                                                                                                 |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 腫瘤引起的疼痛 | 骨轉移    | 常見症狀為疼痛、喪失神經功能、和病理性骨折，在晚上更形嚴重，常見受侵犯部位：<br>1. 顱骨底部：症狀為區域痛，常見於頸部關節的活動度改變。<br>2. 脊椎體：中央背痛是最常見的症狀，嚴重時會伴隨感覺及運動的障礙。<br>3. 全身骨骼：除脊椎外，肋骨和骨盆是早期骨轉移的常見部位。 |
|         | 神經壓迫浸潤 | 1. 顱神經：症狀為局部顏面痛，可能合併暈眩。<br>2. 末梢神經：呈現燒灼痛，可能是持續性或陣發性，也可能兩者兼具，嚴重時可能喪失感覺功能。<br>3. 神經叢：臂神經叢區域型疼痛是乳癌及肺癌病人最常見的症狀，嚴重時甚至延伸至手指頭。                         |
|         | 器官侵襲   | 因腫瘤的侵襲、壓迫、伸展、阻塞或牽扯內臟，疼痛性質會依器官部位（如胰、胃、腸）而有所不同，其疼痛性質多屬鈍痛、鑽痛、撕裂痛、絞痛等。                                                                              |

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 癌症疼痛照護           | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-K14 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 3/14 |

|               |          |                                                                                                                                                   |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 癌症治療<br>引發的疼痛 | 手術後疼痛    | 1. 乳房切除後的數月，其手臂、腋下、胸壁仍可能會疼痛，呈現緊縮及燒灼感。<br>2. 胸廓切開後，在傷口附近會感到疼痛及燒傷感，但會隨著時間增長而減緩，若持續超過 8 個月或已減緩又再復發疼痛，則可能考慮腫瘤復發的可能性。<br>3. 頸部手術後會有持續的燒灼感或感覺遲鈍如電擊一樣的痛。 |
| 癌症治療<br>引發的疼痛 | 化學治療後疼痛  | 1. 末梢神經病變：植物鹼類的化學藥物會造成手足燒灼痛，通常在 4-6 週才會漸漸恢復。<br>2. 類固醇停藥後會加重骨骼痛、肌痛、關節痛。<br>3. 口腔疼痛：化療藥物造成口腔黏膜破損引起疼痛。                                              |
|               | 放射線治療後疼痛 | 主要原因為放射線會引起周邊神經（如上臂神經叢）或脊髓結締組織纖維化而受損，因而導致疼痛。                                                                                                      |

#### （四）癌症疼痛評估

##### 1. 美國〈癌症疼痛處理〉的臨床指導原則中提出五項原則步驟 ABCDE

- (1) 詢問及評估(Ask and Assess)：定期詢問病人及家屬，系統化的評估疼痛。
- (2) 相信(Believe)：相信病人及家屬對於疼痛的陳述及對於治療的反應。
- (3) 選擇(Choose)：選擇合適的疼痛控制治療方法。
- (4) 給予(Deliver)：及時給予減輕疼痛的處置方法。
- (5) 鼓舞與促進(Empower and Enable)：鼓舞病人及家屬的意志，使他們在療程中有最大的自主權。

##### 2. 疼痛評估的時機

疼痛乃一複雜多變的症狀隨著癌症病情的變化、治療的影響及病人的生理及心理狀態而變化，因此在癌症各個治療階段中持續性的疼痛評估是不可或缺的。通常在開始治療時候要定期評估，有新的疼痛要再做評估，在給藥物或非藥物治療疼痛後再適當的觀察時間後，即予評估。

##### 3. 疼痛評估的要項

###### (1) 疼痛史的評估

- A. 疼痛的部位：可使用正面或背面人像繪圖，讓病人說出其感覺疼痛的部位。
- B. 疼痛的性質：紀錄病人對疼痛的描述，如鈍痛、銳痛、燒灼痛等。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 癌症疼痛照護           | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-K14 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 4/14 |

C. 疼痛的強度：可利用數種工具協助評估。

D. 疼痛的模式：疼痛開始的時間、頻率、持續時間。

E. 疼痛的影響因素：何時疼痛最劇烈或最不痛，什麼因素會使疼痛加重或減輕，一天當中何時最痛？是否有任何感情因素會影響疼痛。

F. 病因：癌症、癌症的治療或過程、並存的或非癌症。

G. 目前用藥的效果：疼痛的緩解和副作用，病人對藥物計畫的遵從度。

H. 醫療史：目前所用的藥物、包括處方的、自行購服的、補充的、和另類治療藥物、身體其他疾病狀況。

#### 4. 文化層面的評估

包含：年齡、性別、宗教信仰、疼痛部位、病人對護理人員的期待。

#### 5. 心理層面評估

病人沮喪的程度、目前或最近喪失及生命受創的經驗、家庭和其他支持、病人對疼痛的認知情形及對病人及家屬的意義、精神或宗教上的考量。

#### 6. 生理檢查

完整詳實的身體檢查有助於了解病人的疼痛歷程，神經學檢查則有助於診斷周邊神經病變及運動機能改變。

#### 7. 疼痛評估工具

適用範圍：

(1) 有慢性疼痛表現的病人。

(2) 服用四級以上止痛管制藥物病人，ex：Ultracet、Tramal、Morphine、Durogesic。使用工具：（以疼痛評估量表作為疼痛分數的參考依據）。



|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 癌症疼痛照護           | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-K14 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 5/14 |

### (五) 癌症疼痛處理原則

癌症病人的疼痛問題，經由正確的藥物處置後，約有 60-90%疼痛可以獲得緩解。

#### 1. 衛生署提出治療疼痛三階段目標：

- (1) 第一目標：確保睡眠時不受疼痛影響。
- (2) 第二目標：消除安靜時之疼痛。
- (3) 第三目標：消除站立或移動身體時之疼痛。

#### 2. 世界衛生組織在 1986 年發布癌痛的三階段藥品治療原則：

- (1) 口服(By the mouth)。
- (2) 定時給藥(By the clock)。
- (3) 依三階段給藥(By the ladder)，三階段藥物治療模式，如下：
  - A. 第一階段(輕度疼痛)：使用非類鴉片藥物，如非固醇類消炎藥(NSAIDs)、乙醯胺酚(acetaminophen)，必要時加入其他的輔助藥物，如皮質類固醇(corticosteroids)、抗憂鬱藥(antidepressants)。
  - B. 第二階段(輕度至中度疼痛)：使用弱效的類鴉片藥物，如可待因(codeine)及特拉嗎竇(tramadol)，必要時加入第一階段的藥物。
  - C. 第三階段(中度至重度疼痛)：使用強效的類鴉片藥物，如嗎啡(morphine)、吩坦尼(Fentanyl)，必要時加入第一階段的藥物。
- (4) 因人而異給藥(For the individual)。
- (5) 注意細節(Attention to detail)。

#### 3. 癌症疼痛藥物的使用



|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 癌症疼痛照護           | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-K14 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 6/14 |

| 種類      | 藥名                                                                      | 注意事項                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 非類鴉片藥物  | 非固醇類消炎藥(NSAIDs)<br>Ketorolac(Keto)                                      | 1. 治療輕度至中度疼痛，有抗發炎及解熱作用。<br>2. 會抑制前列腺素形成，因前列腺素有保護腸胃道黏膜的作用，故長期使用易造成消化不良，消化道潰瘍。<br>3. 具有『極限效應』，持續增加劑量不能產生更強的止痛效果。<br>4. 因會阻礙血小板凝集作用，延長出血時間，故不建議和 aspirin 共同使用於止痛。<br>5. NSAIDs 可能會有心臟毒性，在心臟功能衰竭或高血壓的病人，不建議使用。<br>6. 在 NSAIDs 使用期間，若病人腎臟功能變差或有高血壓產生，應調降 NSAIDs 使用。 |
|         | 乙醯胺酚(acetaminophen)<br>Acetaminophen(LACTAM)                            | 1. 治療輕度至中度疼痛，有解熱作用。<br>2. 不具腎毒性也不影響血小板功能，但劑量增加可能產生肝臟毒性。<br>3. 每日最大建議劑量為 600mg。                                                                                                                                                                                 |
| 輔助藥物    | 皮質類固醇(corticosteroids)<br>Dexamethasone、<br>Methylprednisolone(Medason) | 1. 治療因急性炎症所造成的組織疼痛。<br>2. 常見副作用有睡眠障礙。<br>3. 快速減藥會加重疼痛應慢慢減藥。<br>4. 長期使用副作用多，不建議長期使用。                                                                                                                                                                            |
|         | 抗憂鬱藥(antidepressants)<br>Imipramine HCl (Tone)                          | 1. 可用於治療各類的神經病變疼痛(neuropathicpain)，包含由癌症或非癌症所引起。<br>2. 此類藥用於癌痛治療所需劑量較低於抗憂鬱劑量。<br>3. 副作用有口乾、視力模糊、便秘、水腫、心悸。<br>4. 當病人同時使用血清素再吸收(serotonin-reuptake)抑制劑時，應小心發生血清素症候群(Serotonin syndrome)。                                                                         |
|         | 抗癲癇藥(anticonvulsants)<br>Carbamazepine(Tegretol)                        | 1. 用於治療各類的神經病變痛，包含由癌症或非癌症所引起，對三叉神經痛有效。<br>2. 可能造成嗜中性白血球減少，需密切注意血中濃度及全血數值並預防感染。                                                                                                                                                                                 |
| 弱效鴉片類製劑 | 可待因(codeine)<br>Codeine                                                 | 1. 用於輕度至中度疼痛，代謝成嗎啡和 hydrocodone，產生止痛作用，經由腎臟排除。<br>2. 口服劑型的止痛強度約為嗎啡相同劑型的 0.15 倍。<br>3. 具鎮咳作用，經由作用於延腦來抑制咳嗽反射。<br>4. 建議劑量約在 30-130mg（平均 30-80）每 4-6h 給予。<br>>65mg 後必須要注意因其副作用會增加止痛的作用。<br>5. 盡量勿單獨使用，通常與 NSAIDs、Acetaminophen 合                                   |

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 癌症疼痛照護           | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-K14 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 7/14 |

| 種類          | 藥名                                                                                                                      | 注意事項                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                         | 用。                                                                                                                                                                                                           |
|             | 特拉嗎竇(tramadol)<br>Ultraphen、Tramtor、<br>TraMTOR                                                                         | 1. 用於輕度至中度疼痛，其效果及劑量調整空間有限。<br>2. 口服劑型的止痛強度約為嗎啡相同劑型的 0.2 倍。<br>3. 略高於療效劑量時有出現抽搐的可能。<br>4. 易有暈眩、噁心、嘔吐之副作用。                                                                                                     |
| 強效鴉片<br>類製劑 | 嗎啡(morphine)<br>Morphine、Morphine SR、<br>Morphine Sulfate Oral Sol'n                                                    | 1. 為治療嚴重疼痛時的常用藥品。<br>2. 有多種劑型，如口服、直腸、靜脈內、皮下劑型，對於癌痛治療，口服是優先選擇。<br>3. 其代謝物 M-6-G 會產生毒性，腎功能差和老年人須小心用藥。<br>4. 副作用有便秘、噁心、嘔吐、呼吸抑制、尿瀦留、嗜睡。                                                                          |
|             | 芬坦尼(Fentanyl)<br>Fentanyl(Durogesic)Patch、<br>Fentanyl Transdermal Patch、<br>PAINKYL fentanyl (buccal<br>soluble films) | 1. 穿皮貼劑：用於慢性疼痛的治療，包含癌症疼痛。<br>2. 口頰錠(溶片)：常用於治療癌症疼痛的突發性疼痛(breakthrough pain)。這類藥物經由口腔黏膜吸收後直接進入血液，較口服劑型有較快的止痛效果，副作用也會較快發生，因此僅能使用在對於類鴉片藥物有耐受性的病人(opioid tolerant)。<br>3. 依每小時釋出劑量的不同有 12.5、25、50、75、100μg/hr 劑型。 |

#### 4. 非藥物性處置

目前癌症疼痛除了藥物性治療外，尚有非藥物性治療措施，雖不能取代藥物性治療的地位，但對於止痛仍有其輔助之效果。

##### (1) 癌症疼痛的放射線治療

其作用機轉是以治療腫瘤來減少腫瘤的體積或抑制腫瘤的生長，進而保存神經功能、減少內臟壓迫阻塞或減少腫瘤分泌物，進而達到緩解疼痛的效果。其中最常使用的就是骨痛的緩解。

##### (2) 介入性治療

可有效增加藥物治療的效果並減少藥物治療劑量，考量選擇使用介入性治療原因為疼痛主要源自於某一神經或某一交感神經結或無法以藥物或其他非介入性治療達成與其的療效，而不產生無法忍受的副作用，其種類包括

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 癌症疼痛照護           | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-K14 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 8/14 |

有神經阻斷術、外科病灶切除及神經破壞手術治療等。

### (3) 復健治療

對於癌痛舒緩十分重要，其治療目的同樣是為有效幫助增加藥物治療的效果或減少藥物治療的劑量，復健治療最特殊的地方是其方法不只是護理人員能夠執行亦可使病人成為疼痛治療團隊的一員，藉由病人或照護者的參與並學習各式各樣緩和運動及生活姿勢的調整，主動緩解自身的疼痛。復健治療種類有：

A. 物理治療-是指藉著刺激皮膚來減輕疼痛的任何措施

(A) 冷療法(Cryotherapy)：可減緩無髓鞘小神經纖維的傳導速度，可以減輕肌肉的緊繃與疼痛，對剛受傷的腫、痛、肌肉痙攣特別有效，但不適用於動脈血循環不足的末梢血管疾病。

(B) 熱療法(Thermotherapy)：可經由多種機轉像是擴張血管增加血流或是經由溫度受器引發疼痛抑制反射，可舒緩肌肉痙攣及疼痛。肌肉和關節疼痛適用此法，但有些禁忌如:高溫會增加惡性腫瘤的生長速度不宜用在惡性腫瘤的位置，且高溫會增加代謝需求如氧氣需求增加等，不宜用在血液循環不足區；正在發炎的組織不宜使用。

(C) 按摩(Massage)

使用機械性壓力於表淺靜脈和淋巴管可改善血液循環，減輕因水腫導致的疼痛。按摩力道足時，可使微血管、小動脈擴張，改善血液循環。禁忌症為靜脈炎、皮膚裂傷、皮膚病變、骨折、新的手術傷口及外傷處。

(D) 指壓(Acupressure)

此法源自於中國傳統的針灸治療，是將手指壓力施於針灸穴位，刺激壓力纖維，進而關閉脊髓內門路控制機轉，阻斷末梢疼痛衝動的傳送。

(E) 經皮電刺激(TENS)



|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 癌症疼痛照護           | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-K14 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 9/14 |

主要是利用皮膚上的兩個電擊間通以微弱的電流可活化大直徑並有髓鞘的 A $\beta$  纖維，進而關閉末梢神經疼痛衝動門路控制及活化深部纖維釋出內生性嗎啡，進而達到止痛的效果。

## B. 職能治療

藉由外加支持性的輔具，針對癌症疼痛患者日常生活或功能所需之動作，做針對性的個別化訓練其中包括有：

- (A) 個別化輔具製作與訓練。
- (B) 居家無障礙環境評估。
- (C) 居家日常活動訓練。
- (D) 職業技巧訓練。

## C. 認知治療

### (A) 鬆弛療法

首先須有一個安靜的環境，採取舒適的姿勢促使肌肉放鬆可採取：

- a. 雙眼凝視並規律的按摩：張開雙眼並凝視一件遠方的物體，或是閉起眼睛去創造愉快的想像。同時可用手掌的部分在疼痛處附近作圓周式、結實地、律動的按摩，但避免紅腫或有傷口處。
- b. 呼吸鬆弛療法：慢慢的深呼吸同時並繃緊肌肉或肢體，當你吐氣時放鬆肌肉或肢體並感覺到一股張力慢慢流洩。

### (B) 音樂治療

音樂可以使人藉著冥想增加內生性嗎啡量，阻斷不愉快或疼痛的刺激，進而達到放鬆，主要目的是改善病人的舒適度，協助病人獲得自主感，進而能參與止痛計劃，但不單獨使用，也不用在病人劇痛的時候，由於不是每個病人都適用音樂治療，所以要進行前應先評估病人對音樂的喜好。

### (C) 轉移注意力(Distraction)

把注意力集中於某一件事上面並藉此忘記其他的感覺，其可以增加

|      |                  |      |         |        |       |
|------|------------------|------|---------|--------|-------|
| 主題名稱 | 癌症疼痛照護           | 制定單位 |         | 護理部    |       |
| 編號   | A31000-Q03-W-K14 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 10/14 |

耐痛力或提高疼痛的閾值，但並不會使疼痛消失。轉移注意力的方法有許多，如看書、聽音樂等。

#### (D) 想像療法

指利用想像力創造出一個精神的情境，如想像自己在一處很漂亮的海邊聽著海浪聲感覺到海浪打在腳上的清涼，利用這種想像力來去除疼痛的感覺。

#### (六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

### 四、使用表單

(一) 慢性疼痛初步疼痛評估表。

(二) 慢性疼痛持續控制記錄表。



|      |                  |      |         |        |       |
|------|------------------|------|---------|--------|-------|
| 主題名稱 | 癌症疼痛照護           | 制定單位 |         | 護理部    |       |
| 編號   | A31000-Q03-W-K14 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 12/14 |

## 六、參考資料

- (一) 胡文郁、陳宛榆、羅淑芬、陳書毓、黃瀚心、陳幼貴(2013)．成人癌症疼痛臨床照護指引－第一版與第二版修訂對照表．腫瘤護理雜誌，13 卷增訂刊，100-105。
- (二) 台灣癌症安寧緩和醫學會(2018)．癌症疼痛之藥物治療指引（第七版）．台北：台灣癌症安寧緩和醫學會。
- (三) 台灣疼痛醫學會(2024)．癌症疼痛照護及成癮性麻醉藥品使用參考手冊（專業版第二版）．台北：衛生福利部食品藥物管理署。

## 七、附件

- (一) 慢性疼痛初步疼痛評估表書寫原則（見護理紀錄書寫原則與評核表 QM-4 4-6）。

|      |                  |      |         |        |       |
|------|------------------|------|---------|--------|-------|
| 主題名稱 | 癌症疼痛照護           | 制定單位 |         | 護理部    |       |
| 編號   | A31000-Q03-W-K14 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 13/14 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                                       | 備註                                                                           |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 99.01.20  | 1.0 | 新制定。                                                                                       | 99 年 01 月 20 日<br>護理部照護標準委員會通過。                                              |
| 99.08.31  | 2.0 | 配合本院 SOP 格式改版。                                                                             |                                                                              |
| 101.08.31 | 2.1 | (1)醫護部改護理部。<br>(2)修改目的。<br>(3)修改流程圖內容：突發性疼痛大於三次。                                           | 101 年 08 月 30 日護理部照護標準委員會通過。                                                 |
| 102.02.08 | 3.0 | 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。                                                                |                                                                              |
| 103.06.30 | 3.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                            |                                                                              |
| 104.08.31 | 3.1 | (1)第三項說明內容部份增修。<br>(2)增修第六項參考資料。                                                           | 104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。                                                 |
| 105.08.31 | 3.2 | 新增參考文獻出處於內文中。                                                                              | 105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。                                                 |
| 106.08.31 | 3.2 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                            |                                                                              |
| 107.06.29 | 3.2 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                            |                                                                              |
| 107.09.12 | 3.3 | 1. 第二項新增（含中興分院）。<br>2. 第三項第五目之 3 弱效類鴉片製劑 Tramadol 新增易有之副作用。強效鴉片類製劑 Morphine 改為 15mg，極附註劑型。 | 107 年 09 月 12 日護理長會議通過。                                                      |
| 108.09.23 | 3.4 | 第三項第六日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。                                              | 108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。                              |
| 109.08.18 | 3.5 | 第三項第二目之 2(3)、第三目、第四目之 3(1)、5(1)、7(2)、第五目之 2(1~5)、3 內容部份修辭。                                 | 109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；<br>109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。 |



|      |                  |      |         |        |       |
|------|------------------|------|---------|--------|-------|
| 主題名稱 | 癌症疼痛照護           | 制定單位 |         | 護理部    |       |
| 編號   | A31000-Q03-W-K14 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 14/14 |

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                  | 備註                                                                           |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 110.10.19 | 3.6 | 1. 第三項說明內容 APA 格式修訂。<br>2. 第六項參考資料修訂。                 | 110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過；<br>110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。 |
| 111.11.08 | 3.7 | 1. 更新第六項參考資料。<br>2. 內文參考文獻引用刪除。                       | 111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過；<br>111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。 |
| 112.10.26 | 3.7 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                       |                                                                              |
| 113.12.17 | 3.8 | 刪除第六項參考資料年限較久參考文獻。                                    | 113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過；<br>113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。 |
| 115.01.06 | 3.9 | 1.第三項第五目：第 2 點、之(5)、第 3 點內容部份修辭及新增內容。<br>2.第六項新增參考資料。 | 114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過；<br>114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。 |
|           |     |                                                       |                                                                              |
|           |     |                                                       |                                                                              |
|           |     |                                                       |                                                                              |
|           |     |                                                       |                                                                              |